

DOR AGUDA — AVALIAR, ESCALONAR, REAVALIAR

ESCADA ANALGÉSICA DA OMS ADAPTADA AO PS

Degrau	Intensidade (EVN)	Fármacos
1	Leve (1-3)	Não opioides: dipirona, paracetamol, AINE +/- adjuvantes
2	Moderada (4-6)	Opioide fraco (codeína, tramadol) + não opioide +/- adjuvante
3	Intensa (7-10)	Opioide forte (morfina) + não opioide +/- adjuvante
Multimodal	Qualquer	Combinar classes com mecanismos diferentes para reduzir dose e efeitos adversos
Via	Conforme gravidade	VO se possível; IV titulada na dor intensa/instável
Adjuvantes	Dor neuropática/específica	Anticonvulsivante (gabapentina), antidepressivo, corticoide, antiespasmódico

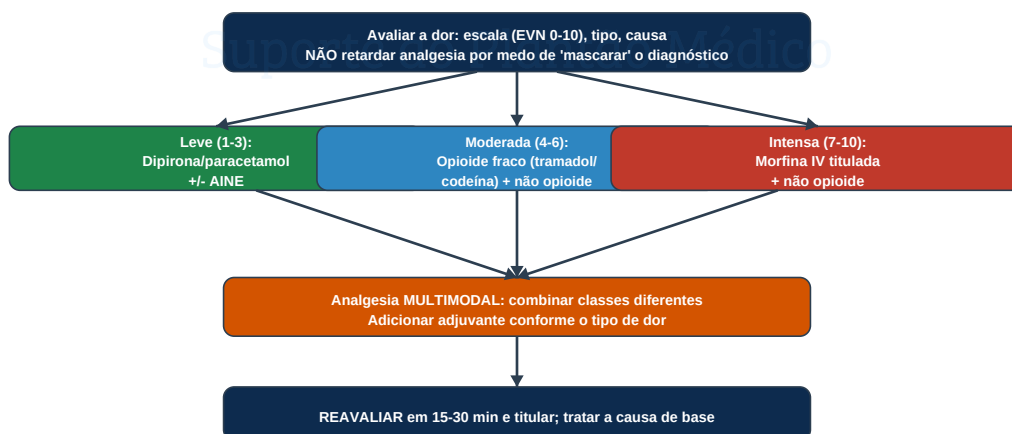
ANALGÉSICOS — DOSES NO ADULTO

Rx NÃO OPIOIDES, OPIOIDES E ADJUVANTES

Dipirona: 1 g (até 2 g) IV/VO a cada 6h — bom antitérmico e antiespasmódico
Paracetamol: 500-1000 mg VO 6/6h (máx 3-4 g/dia) — cuidado em hepatopatas
Cetoprofeno: 100 mg IV 12/12h; Ibuprofeno 400-600 mg VO 8/8h — AINE (evitar em IRA, sangramento, idoso frágil)
Tramadol: 50-100 mg IV/VO 6-8h (máx 400 mg/dia) — opioide fraco; cuidado com serotoninérgicos (risco de síndrome serotoninérgica) e limiar convulsivo
Codeína: 30-60 mg VO 6/6h, frequentemente associada ao paracetamol
Morfina: 0,05-0,1 mg/kg IV, titular 2-4 mg a cada 5-10 min até analgesia — opioide forte de escolha na dor intensa
Antídoto opioide: Naloxona 0,04-0,4 mg IV em caso de depressão respiratória
Adjuvantes: gabapentina/pregabalina e amitriptilina (dor neuropática); hioscina (cólica); dexametasona (componente inflamatório)

ABORDAGEM DA DOR AGUDA

DOR — MEDIR, TRATAR, REAVALIAR



SEGURANÇA E POPULAÇÕES ESPECIAIS

CUIDADOS QUE EVITAM IATROGENIA

- AINE: evitar em lesão renal aguda, hipovolemia, sangramento digestivo, IC descompensada, idoso frágil e gestante (3o trimestre)
- Paracetamol: reduzir dose em hepatopatia; atenção a apresentações combinadas (risco de superdose)
- Opioides: monitorar nível de consciência e frequência respiratória; ter naloxona disponível
- Idoso: começar com doses menores; risco de delírium e queda; preferir multimodal
- Gestante: paracetamol é o mais seguro; evitar AINE no 3o trimestre; opioides com cautela
- Tramadol: risco de síndrome serotoninérgica (com ISRS/IMAO) e de convulsão

DOR POR TIPO — ESCOLHA DIRECIONADA

Dor Nociceptiva / Visceral

- Cólica renal/biliar: AINE (cetoprofeno) é muito eficaz + antiespasmódico
- Dor óssea/inflamatória: AINE + dipirona/paracetamol
- Dor pós-trauma intensa: morfina IV titulada
- Cefaleia: dipirona/AINE; evitar opioide de rotina
- Cólica abdominal: hioscina + dipirona

Dor Neuropática

- Características: queimação, choque, formigamento, alodínia
- Primeira linha: gabapentina/pregabalina ou amitriptilina/duloxetina
- Opioides têm resposta limitada isoladamente
- Bloqueios anestésicos podem ser úteis (ex.: neuralgia)
- Tratar a causa (herpes zoster, radiculopatia, neuropatia)

BOAS PRÁTICAS NO PS

ANALGESIA DE QUALIDADE

- ☐ Medir a dor com escala validada (EVN) na admissão e após cada intervenção
- ☐ Analgesia precoce não atrapalha o diagnóstico do abdome agudo (evidência consolidada)
- ☐ Escalonar pela intensidade e usar abordagem multimodal
- ☐ Titular opioide IV na dor intensa e reavaliar em 15-30 min
- ☐ Ajustar para idoso, hepatopata, nefropata e gestante
- ☐ Registrar a resposta analgésica e tratar a causa de base

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com dor abdominal intensa (EVN 9). Qual a conduta analgésica inicial mais adequada?

- A) Aguardar a avaliação cirúrgica antes de qualquer analgesia para não mascarar o diagnóstico
- B) Morfina IV titulada associada a analgésico não opioide, com reavaliação em 15-30 min
- C) Apenas paracetamol oral
- D) Tramadol oral em dose única e alta
- E) AINE em dose máxima isolada

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em qual situação o uso de AINE deve ser evitado?

- A) Cólica renal em jovem hígido
- B) Lesão renal aguda, hipovolemia, sangramento digestivo ou IC descompensada
- C) Dor osteomuscular leve
- D) Febre com mialgia
- E) Entorse de tornozelo em adulto saudável

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual a primeira linha para dor NEUROPÁTICA?

- A) Morfina isolada
- B) Anticonvulsivante (gabapentina/pregabalina) ou antidepressivo (amitriptilina/duloxetina)
- C) AINE em dose máxima
- D) Paracetamol isolado
- E) Corticoide em pulso

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente recebeu opioide para dor intensa e evolui com sonolência e FR de 8 irpm. Qual a conduta?

- A) Aumentar a dose do opioide
- B) Administrar naloxona e suporte ventilatório
- C) Administrar flumazenil
- D) Apenas observar
- E) Iniciar AINE

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

O que significa analgesia MULTIMODAL?

- A) Usar a maior dose possível de um único fármaco
- B) Combinar fármacos de classes/mecanismos diferentes para potencializar a analgesia e reduzir efeitos adversos
- C) Usar apenas opioides em todas as etapas
- D) Alternar a via oral e venosa do mesmo fármaco
- E) Tratar a dor somente com medidas não farmacológicas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor intensa (EVN 9) deve ser tratada com opioide forte (morfina IV titulada) associado a não opioide, com reavaliação em 15-30 min. A analgesia precoce NÃO mascara o diagnóstico do abdome agudo — evidências mostram que melhora a avaliação e o conforto.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

AINE deve ser evitado em lesão renal aguda, hipovolemia, sangramento digestivo, IC descompensada, idoso frágil e gestante no 3o trimestre, pelo risco de agravar a função renal, sangramento e descompensação. Nesses casos, preferir dipirona/paracetamol e opioides conforme a intensidade.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A dor neuropática (queimação, choque, alodínia) responde mal a opioides isolados. A primeira linha são anticonvulsivantes (gabapentina/pregabalina) e antidepressivos (amitriptilina, duloxetina), além de tratar a causa.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Depressão respiratória por opioide (sonolência + FR baixa) é tratada com naloxona (0,04-0,4 mg IV, titulada) e suporte ventilatório. Flumazenil é antídoto de benzodiazepínico, não de opioide.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Analgesia multimodal consiste em combinar fármacos de classes e mecanismos diferentes (ex.: dipirona + AINE + opioide + adjuvante), potencializando o efeito analgésico e permitindo doses menores de cada um, com menos efeitos adversos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico